

Información Paciente

Nombre : Diego Armando Colil Abarca
Edad : 33a 3m 10d
Dirección : Tucumán 8855

Rut : 17.049.791-0
Fecha Nacto: 09/11/1988
Comuna : La Cisterna

N° Archivo : 2200681
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 7356 4692

N° Epicrisis
295454

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Básica (4to Piso)

Fecha Ingreso : 11/01/2022 20:05

Días Estadía: 39

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 19/02/2022 23:02

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI HSR: 11/01/22
FI UTIM: 12/01/22
FI UPC: 12/01/22

ANTECEDENTES

MÓRBIDOS: Obesidad grado 3.

QUIRÚRGICOS: (-)

FÁRMACOS: (-)

ALERGIAS: (-)

HÁBITOS: TBQ (-), OH ocasional, Drogas (-)

INMUNIZACIONES: Flu 2021, sin vacuna COVID

SOCIAL: Vive con hermanos

HOSPITALIZACIONES RECIENTES: (-)

MOTIVO DE INGRESO: Dificultad respiratoria

HISTORIA CLÍNICA

Hombre de 33 años, sin antecedentes mórbidos, comienza el 01/01/22 con fiebre y tos. Es evaluado en APS, donde se pesquisa PCR SARS COV 2 positiva, por lo que se deriva a residencia sanitaria. Evoluciona con fiebre elevada de difícil manejo y desaturación, por lo que se deriva para hospitalización.

Ingresa a SU CASR en buenas condiciones generales, normocárdico, normotenso, afebril, pero saturación límite con 3 litros de oxígeno, sin uso de musculatura accesoria. Al examen físico se describe bien perfundido, vigil, eupneico, sin uso de musculatura accesoria, RR2T no se auscultan soplos, MP disminuido globalmente.

Dentro de exámenes de ingreso destaca alza de PI, discreta alcalosis respiratoria.

Se solicita radiografía de tórax donde se observa infiltrados intersticiales bilaterales difusos.

Ingresa a UTIM donde evoluciona con deterioro ventilatorio, aumento de parámetros inflamatorios, requerimientos de CNAF y uso de musculatura accesoria, por lo que se decide VMI y traslado a UCI y posteriormente a UTIM, donde evoluciona:

Hemodinamia: estable, requirió de forma transitoria DVA en contexto de sedoanalgesia. Posteriormente no ha sido conflicto, no requiere VDO. Persiste con taquicardia sinusal, inicialmente no fue posible descartar TEP por IMC elevado. Finalmente 10/02

Fecha Epicrisis : 19/02/2022 23:12

Fecha Última Actualización: 19-02-2022 23:12:48

Página 2 de 3

se logra tomar AngioTAC que descarta TEP. Impresiona componente de hiperadrenergia y miopatía de paciente crítico. Se inicio furosemda por BH persistentemente (+), con objetivo BH -500 a -1000.

Dado alteraciones al ECG (T invertidas y onda Q prominente en D III) y paciente con FRCV, EcoTT ambulatorio.

Respiratorio: ingresa con insuficiencia respiratoria aguda parcial secundaria a NAC COVID19, inicialmente en UTIM con CNAF; evolución tórpida, requirió IOT por 16 días, BNM 12 días y prono por 8 días, PAFI hasta 40, tras prono recupera > 400. Extubado el 29/01 salda a CNAF y VMNI nocturna modalidad CPAP por sospecha de SAHOS. Evolución favorable, logra paso a naricera y suspensión requerimientos de O2 hace más de 7 días.

Infeccioso: Múltiples hits ya tratados:

- SDRA COVID, recibe protocolo RECOVERY que completa el 23/01.

- Bacteremia por *S. epidermidis* y *hominis* MS, recibe 7 días de Cloxacilina entre el 16 y 23/01.

- NAVM *E. coli* y *M. morganii* e ITU KPN MS, recibe Imipenem desde el 18/1.

- 25/1 se agrega Vancomicina por fiebre, en nuevos cultivos destaca HC (+) *S. haemolyticus*, Providencia stuartii, punta CVC (+) *S. haemolyticus* MR. Evaluado por infectología, se indica por sensibilidad límite a Vancomicina (CIM 2), curso de Linezolid (10 días) + Amikacina (5 días) + Imipenem (17 días).

- 13/02 presentas peak febril hasta 38.3, sin repercusión HDN. Se inició tratamiento antibiótico con imipenem + linezolid en base a microbiología previa. Del estudio:

13/02: SU inflamatorio, UC positivo para KPN MS

12/02: HC I (P), HC II (+) BGN a las 12 horas, correspondiente a *E. coli* con R ciprofloxacino, intermedio a ampicilina sulbactam, recibe 3 días de carbapenémicos y se traslapó a Ceftriaxona con plan de completar 7 días con unidad de hospitalización domiciliaria.

Renal: sin alteración de función renal, pero BH persistentemente acumulado, por lo que se mantiene terapia depleitiva. Cursa con hipokalemia persistente a pesar de cargas EV, se disminuye terapia depleitiva y se asocia espironolactona.

Metabólico: pacientes con HGT en rangos. Hiperglicemia matinal estudio en ambulatorio.

Rehabilitación:

DELIRIUM: Sin delirium, se privilegian medidas ambientales

FNA: sin disfagia, sin restricción en consistencia, dado de alta desde la UCI.

Motor: paresia M3-4 en ESI con paresias que impresionan por lesión en plexo braquial debido a prono, evaluado por neurología, impresiona componente de miopatía/neuropatía de paciente crítico, sugieren TO y control ambulatorio con neurología para EMG. Mantener KNT motora, paciente rechaza uso de pregabalina.

Actualmente logra caminar con burrito por la pieza.

LPP: zonas de apoyo indemne, se mantuvo con cambio de posición frecuentes.

Profilaxis: Dado paciente con IMC sobre 50 se ajusta dosis de tromboprofilaxis de HBPM.

DIAGNÓSTICOS

1. Insuficiencia respiratoria aguda catastrófica en resolución

1.1. Neumonía grave COVID 19, día +47 (FIS 01/01)

1.1.1. VMI 12/01- 29/01, BNM 13/01- 25/01 y PP 17/01 -25/01

2. Sepsis en tratamiento

2.1. Bacteriemia por *E. coli* sensible

2.2. ITU KPN MS

3. Hiponatremia leve resuelta e hiperkalemia moderada

4. Paciente crítico crónico

4.1. Taquicardia sinusal Obs hiperadrenergia post UPC

4.2. Neuropatía periférica en Extremidad Superior izquierda

4.2.1. Obs comprensión nerviosa ESI en estudio

4.3. Miopatía de paciente crítico

5. ITS asociada a infección de CVC tratadas

6. *Staphylococcus haemolyticus* MS y *Providencia Stuartii* MR (25/01)

7. Cultivo punta catéter (+) *Morganella morganii* MS y *Staphylococcus haemolyticus* MR sensible a vanco (25/01)

Fecha Epicrisis : 19/02/2022 23:12

Página 2 de 3

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 19-02-2022 23:12:48

8. NAVM E. Coli + Morganella Morganii tratada (18/01)
9. ITU Klebsiella Pneumoniae MS tratada (18/01)
10. Bacteremia S. epidermidis MS + Staph Hominis MS tratada (12/01)
11. Antecedentes: Obesidad mórbida (IMC > 50). Peso estimado 140 Kg

Diagnóstico de Egreso

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA -
COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO -
CHOQUE SÉPTICO -
MIOPATIA, NO ESPECIFICADA -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente en BCG, HDN estable, normocárdico, normotenso. Se deriva a UHD para:

- completar tratamiento antibiótico
- Kinesioterapia respiratoria y motora

Plan Post Alta

INDICACIONES

Retomar paulatinamente actividades de la vida diaria
Rehabilitación motora por equipo de Unidad de Hospitalización Domiciliaria
Régimen común
Ceftriaxona 2 gramos al día EV por Unidad de Hospitalización domiciliaria, hasta el 20/02 inclusive
Paracetamol 1 gramo cada 8 horas vía oral
Realizar ecocardiograma, se adjunta orden
Control en neurología para EMG, se envía IC
Control en su consultorio para estudio síndrome metabólico, seguimiento de glicemia alterada en ayuno
En caso de dificultad respiratoria, fiebre persistente o en caso que estime necesario, acudir a servicio de urgencias más cercano.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Hipograso

Medicamentos :

Controles



Bec. Geraldine Jaia Becado Kohn
INTERNO



Bec. María Jesús Ballart Espinosa
Becado/Residente



Paula Arriagada San Martín
Médico Tratante (Staff)